

אירועים ובי־נפגעים

הערכת נפגע בודד באירוע רב־נפגעים – אר"ן (S.T.A.R.T.) ← 165

סכימת טריאז' כללית באירוע רב־נפגעים SALT (אר"ן) ← 166

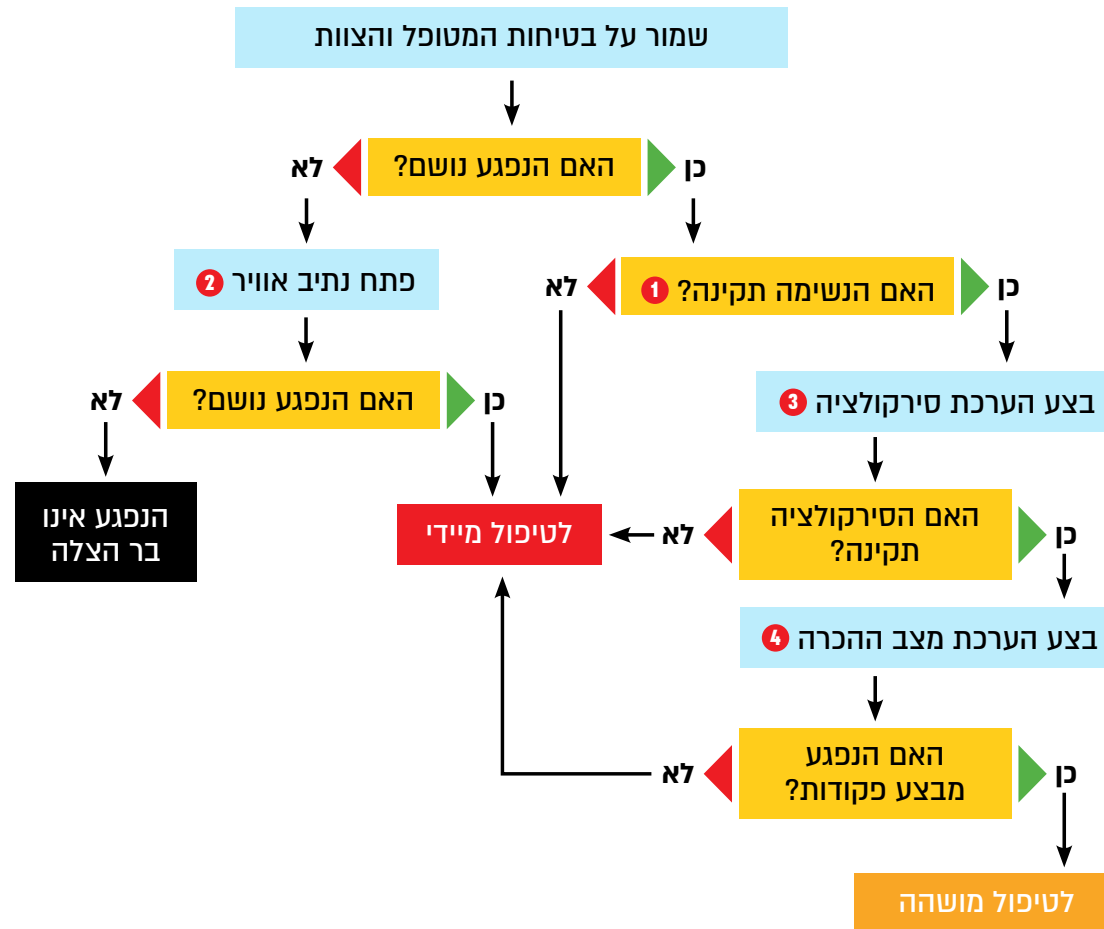
דגשים עיקריים באר"ן ← 167

סימון ורישום באמצעות תג מיון ופינוי נפגעים באר"ן ← 169

אירוע טוקסיקולוגי המוני ← 171

עקרונות תורת הטיפול באירוע ביולוגי חריג (אבח"ר) ← 173

Simple Triage and Rapid Treatment



1 נשימה תקינה במבוגר

10–30 נשימות בדקה.

2 פתיחת נתיב אוויר

בדרך ידנית (משיכת הלסת) ו/או באמצעות החדרת מנתב אוויר פלסטי.

3 הערכת סירקולציה

+ הערכת דופק רדיאלי (נמוש היטב, חלש או לא נמוש, קצב סדיר או לא סדיר).

+ הערכת מילוי קפילרי (קטן מ־2 שניות).

4 הערכת מצב ההכרה – נבדוק את יכולת המטופל לבצע פקודות פשוטות.

דגשים בילדים

+ ילד שאינו נושם גם לאחר פתיחת נתיב אוויר – יש לבדוק דופק טרם קביעה שאינו בר הצלה.

+ אם נמוש דופק – יש לבצע 5 הנשמות טרם קביעה שאינו בר הצלה.

+ נשימה תקינה בילדים – 15–45 נשימות בדקה. 2

+ הערכת מצב הכרה בילדים לפי AVPU 4

– אם הילד ערני או פוקח עיניים כתגובה לקול – יתויג לטיפול מושהה.

– אם הילד פוקח עיניים רק כתגובה לכאב (או שכלל אינו פוקח עיניים) – יתויג לטיפול מיידי.